



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN
GERIATRI
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



**PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN GERIATRI
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan angka harapan hidup di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah populasi lanjut usia (lansia). Kelompok lansia memiliki karakteristik khusus, antara lain adanya penyakit kronis multipel, penurunan fungsi organ, gangguan mobilitas, gangguan kognitif, serta ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

Pelayanan geriatri di rumah sakit tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara multidisiplin. Pendekatan ini dikenal dengan pelayanan geriatri komprehensif (Comprehensive Geriatric Assessment/CGA), yang melibatkan dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kemampuannya. Selain itu, dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, pelayanan kepada populasi khusus termasuk lansia menjadi bagian dari standar pelayanan berfokus pada pasien serta keselamatan pasien.

Pelayanan geriatri yang tidak terkoordinasi dengan baik berisiko menimbulkan perpanjangan lama rawat, peningkatan kejadian jatuh, polifarmasi, interaksi obat yang merugikan, malnutrisi, dekubitus, hingga peningkatan angka rehospitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan tim pelayanan geriatri yang terstruktur dengan program kerja yang jelas, terukur, dan terdokumentasi.

Program kerja Tim Pelayanan Geriatri disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan yang terintegrasi, mulai dari skrining pasien geriatri, asesmen komprehensif, perencanaan perawatan terpadu, monitoring evaluasi, hingga perencanaan pemulangan pasien (discharge planning). Program ini juga mendukung pemenuhan indikator mutu dan keselamatan pasien sesuai standar akreditasi.

Dengan adanya Program Kerja Tim Pelayanan Geriatri, diharapkan pelayanan terhadap pasien lansia di rumah sakit dapat berjalan efektif, efisien, bermutu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarganya.. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;



5. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Program Kerja Tim Pelayanan Geriatri adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien lanjut usia (lansia) secara komprehensif, terintegrasi, multidisiplin, dan berkesinambungan, guna memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit serta regulasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Indonesia.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan pelayanan geriatri yang bermutu, aman, efektif, dan berfokus pada pasien lansia melalui pendekatan multidisiplin dan pelayanan geriatri komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, serta menurunkan angka komplikasi, kecacatan, dan rehospitalisasi pada pasien lansia.

3. Tujuan Khusus

- a. Menyelenggarakan skrining pasien lansia berisiko tinggi secara sistematis di seluruh unit pelayanan.
- b. Melaksanakan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) yang meliputi aspek medis, fungsional, psikologis, sosial, dan nutrisi
- c. Menyusun rencana asuhan terpadu berbasis tim multidisiplin sesuai kebutuhan individual pasien lansia.
- d. Meningkatkan keselamatan pasien lansia melalui pencegahan risiko jatuh, polifarmasi, malnutrisi, dekubitus, delirium, dan infeksi terkait pelayanan kesehatan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan terapi obat pada pasien lansia untuk mencegah efek samping dan interaksi obat yang tidak diinginkan
- f. Melaksanakan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait perawatan lanjutan, kepatuhan terapi, serta pencegahan komplikasi.
- g. Menyelenggarakan discharge planning yang terstruktur untuk menjamin kesinambungan pelayanan setelah pasien pulang.
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan geriatri melalui pelatihan dan evaluasi berkala.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan geriatri melalui indikator mutu sesuai standar akreditasi.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 MISI

8. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
9. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
10. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

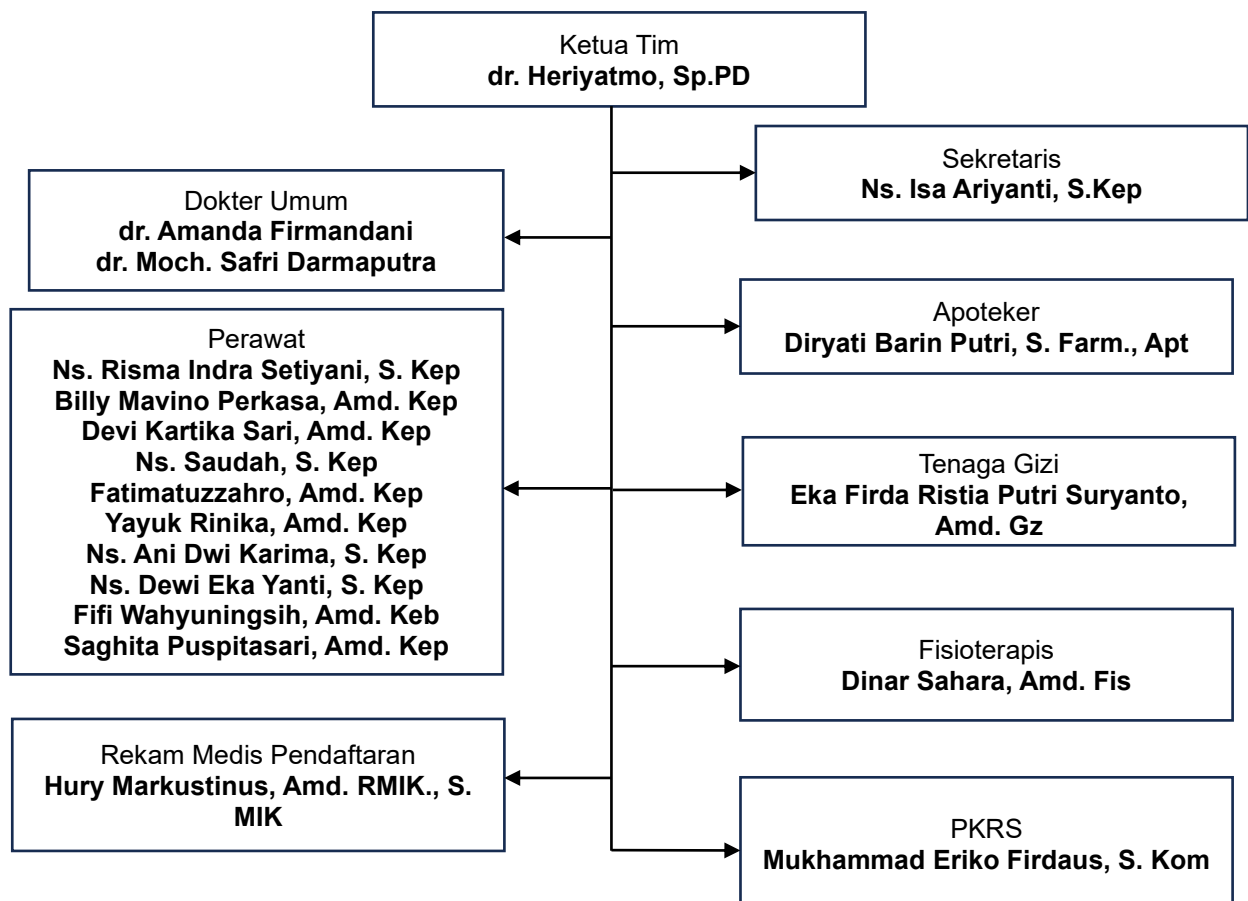
2.3 MOTTO

“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 (7) NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK





BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

Tabel 2.2.1 Kegiatan Pokok

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Membuat perencanaan dan revisi regulasi	a. Melakukan review Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat) b. Melakukan revisi Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat) c. Membuat Pedoman Kerja Tim Geriatri (Melalui rapat) d. Membuat Program Kerja Pelayanan Tim Geriatri tahun 2026 (Melalui rapat) e. Merevisi SPO terkait Geriatri (Melalui rapat)
2	Peningkatan Kompetensi SDM	a. Melaksanakan Diklat untuk Tim Geriatri . b. Sosialisasi prosedur pelayanan geriatri c. Pelatihan pencegahan risiko jatuh
3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Klinis	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri : Supervisi RM asuhan geriatri /kelengkapan dari: 1) Form Skrinning geriatri di IGD, rawat inap, rawat jalan 2) Form Pengkajian awal keperawatan pada point Assemen geriatri 3) Form Discharge Planning 4) Form Edukasi 5) Form RPP/RM (rujukan edukasi....) 6) Mengumpulkan data pencapaian kunjungan geriatric Irja, Irna, rujuk, meninggal, PRB, 10 besar penyakit Geriatri, demografi geriatri (lihat di pengkajian kebutuhan edukasi: usia, pekerjaan, pendidikan, keyakinan, hambatan) 7) Home visite dan Home Care 8) Membuat laporan (bulanan, triwulan, tahunan) (dalam laporan harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL sesuai tata naskah)
4	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan Geriatri	a. Membuat Daftar Indikator Mutu geriatri b. Membuat Profil Indikator mutu Geriatri c. Melakukan pengukuran mutu geriatri d. Membuat laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL) e. Memberikan feedback kepada unit terkait ((Melalui rakor)
5	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi program PKRS untuk Geriatri	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri mengukur capaian Edukasi individu dan kelompok tetang : 1) Nutrisi lansia 2) Upaya perawatan lansia 3) PHBS 4) Risiko jatuh/ Manrisk



		b. Melakukan pembinaan komunitas F-Kul 1) Untuk aktivitas fisik (Senam Lansia, Yoga Lansia) dan Bimroh (pengajian Sirrotul Jannnah). c. Membuat Laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL) d. Memberikan feetback kepada unit terkait (Melalui rakor)
--	--	---

3.2 Sasaran

Tabel 3.3.1 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Membuat perencanaan dan revisi regulasi						
	a Melakukan review Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat)	1) Menyesuaikan pedoman dengan standar Akreditasi Rumah Sakit 2) Meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan pasien geriatri	Seluruh tim yang terlibat dalam pedoman geriatri	Rapat tim geriatri	Standar akreditasi rumah sakit	Pedoman yang digunakan di unit pelayanan sudah versi terbaru.	
	b Melakukan revisi Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat)	1) Memperbarui pedoman pelayanan geriatri agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi terbaru, dan kebutuhan pelayanan di rumah sakit. 2) Menjamin kesesuaian pedoman dengan standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan geriatri	Rapat tim geriatri	Tersusunnya dokumen pedoman versi terbaru	Pelayanan geriatri di rumah sakit berjalan sesuai pedoman terbaru.	
	c Membuat Pedoman Kerja Tim Geriatri (Melalui rapat)	1) Menyusun pedoman kerja yang jelas sebagai acuan operasional bagi Tim Geriatri dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi dan komprehensif	Seluruh anggota Tim Geriatri	Rapat koordinasi dan pembentukan tim penyusun pedoman	Tersusunnya dokumen Pedoman Kerja Tim Geriatri yang lengkap, sistematis, dan	Tim geriatri bekerja sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam pedoman	



		2) Menjamin keseragaman peran, tugas, dan tanggung jawab setiap anggota tim geriatri.			sesuai standar akreditasi		
	d Membuat Program Kerja Pelayanan Tim Geriatri tahun 2026 (Melalui rapat)	1) Menyusun program kerja Tim Geriatri Tahun 2026 secara terstruktur, terukur, dan sesuai kebutuhan pelayanan pasien geriatri	Seluruh anggota Tim Geriatri	Rapat koordinasi tim geriatri	Tersusunnya dokumen program kerja Tim Geriatri Tahun 2026	Tersedianya dokumen program kerja yang disahkan oleh manajemen.	
	e Merevisi SPO terkait Geriatri (Melalui rapat)	1) Menjamin kesesuaian SPO dengan standar akreditasi rumah sakit terkait pelayanan geriatri	Tim Pelayanan Geriatri	Rapat koordinasi geriatri	Tersedianya SPO	Tersedianya dokumen SPO terbaru	
2	Peningkatan Kompetensi SDM						
	a. Melaksanakan diklat untuk tim geriatri	1) Meningkatkan kompetensi Tim Geriatri dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, terpadu, dan berfokus pada pasien usia lanjut	Seluruh anggota Tim Geriatri	Pelatihan/diklat internal atau eksternal terkait pelayanan geriatri	≥ 80% anggota Tim Geriatri mengikuti pelatihan	Tersedianya sertifikat atau bukti pelatihan	
	b. Sosialisasi prosedur pelayanan geriatri	1) Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap prosedur pelayanan geriatri yang berlaku di rumah sakit 2) Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien geriatri	Seluruh tenaga Kesehatan di RS	Sosialisasi/penyuluhan prosedur pelayanan geriatri	Minimal 1 kali dalam setahun	Persentase unit yang telah mengikuti sosialisasi	
	c. Pelatihan pencegahan risiko jatuh	1) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan	Tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam perawatan pasien lansia	Pelatihan/in-house training	Minimal 1 kegiatan	Tersedianya bukti pelatihan	



		mencegah risiko jatuh pada pasien, khususnya pasien geriatri		pencegahan risiko jatuh	pelatihan per tahun		
3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Klinis						
	Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri : a. Supervisi RM asuhan geriatri /kelengkapan : 1) Form Skrining geriatri di IGD, rawat inap, rawat jalan	1) Melakukan identifikasi pasien geriatri dengan risiko masalah kesehatan	Seluruh pasien usia ≥ 60 tahun	Skrining awal pasien geriatri	100% pasien usia ≥ 60 tahun dilakukan skrining geriatri	Peningkatan kualitas hidup pasien geriatri selama perawatan	
	2) Form Pengkajian awal keperawatan pada point Assemen geriatri	Mengidentifikasi secara dini kondisi kesehatan pasien geriatri secara holistik (bio-psiko-sosial-spiritual)	Seluruh pasien usia ≥ 60 tahun yang mendapatkan pelayanan	Pengkajian awal keperawatan	100% pasien geriatri (≥ 60 tahun) dilakukan pengkajian awal keperawatan	Peningkatan kepuasan pasien/keluarga terhadap pelayanan keperawatan	
	3) Form Discharge Planning	Mempersiapkan pasien dan keluarga dalam perawatan mandiri setelah pulang	Seluruh pasien usia ≥ 60 tahun yang mendapatkan pelayanan	Form discharge planning	100% pasien rawat inap dilakukan	Peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan kontrol	



					discharge planning		
	4) Form edukasi	Meningkatkan pengetahuan dan kemandirian pasien dalam menjaga kesehatan	Pasien, keluarga, masyarakat	Pengisian form edukasi	100% pasien mendapatkan edukasi sesuai kebutuhan klinis	Pengetahuan meningkat	
	5) Form RPP/RM (rujukan edukasi....)	Menjamin pasien dan/atau keluarga mendapatkan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan klinis dan kondisi kesehatan	Pasien dan Keluarga pasien yang terlibat dalam perawatan	Pengisian Form RPP/RM (rujukan edukasi)	100% pasien yang membutuhkan edukasi teridentifikasi dalam Form RPP/RM	Peningkatan kepatuhan pasien terhadap terapi/pengobatan	
	6) Mengumpulkan data pencapaian kunjungan geriatric Irja, Irna, rujuk, meninggal, PRB, 10 besar penyakit Geriatri, demografi geriatri (lihat di pengkajian kebutuhan edukasi: usia,	Menyediakan data kunjungan pasien yang akurat, lengkap	Seluruh unit pelayanan	Pengumpulan data kunjungan harian dari setiap unit pelayanan	100% unit pelayanan melaporkan data kunjungan	Kelengkapan laporan, akurasi data, pemanfaatan data	



	pekerjaan, pendidikan, keyakinan, hambatan)						
	7) Home visite dan Home Care	Pelayanan berkelanjutan dan peningkatan kemandirian pasien	Pasien kronis, lansia, pasca rawat, keluarga	Home visit, home care (asuhan, edukasi, monitoring)	≥90% kunjungan sesuai jadwal	Kepatuhan SOP, pemahaman pasien, penurunan komplikasi	
	8) Membuat laporan (bulanan, triwulan, tahunan) (dalam laporan harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL sesuai tata naskah)	Menyediakan informasi komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan geriatri	Semua unit terkait pelayanan geriatri	Penyusunan laporan program	1 laporan setiap bulan	Tersusunnya laporan pelayanan geriatri	
4	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan Geriatri						
	a. Membuat Daftar Indikator Mutu geriatri	Menyusun indikator mutu pelayanan geriatri yang terstandar sebagai alat ukur	1) Tim mutu/PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)	Kegiatan manajerial dan	Tersusunnya daftar indikator mutu geriatri	100% indikator mutu geriatri tersusun lengkap	



		dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien lansia, serta kepatuhan terhadap standar akreditasi dan ketentuan Permenkes	2) Tim pelayanan geriatri	pengembangan mutu	yang mengacu pada standar akreditasi dan Permenkes terbaru		
	b. Membuat Profil Indikator mutu Geriatri	Menyusun profil indikator mutu geriatri yang komprehensif dan terstandar	1) Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) 2) Tim pelayanan geriatri	Kegiatan manajerial dan pengembangan mutu	Tersusunnya profil setiap indikator mutu geriatri secara lengkap dan sistematis	100% indikator mutu geriatri memiliki profil indikator yang lengkap	
	c. Melakukan pengukuran mutu geriatri	Menilai dan memantau mutu pelayanan geriatri	1) Tim PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) 2) Tim pelayanan geriatri	Kegiatan operasional dan manajerial berupa pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data indikator mutu geriatri	Data yang dikumpulkan valid, akurat, dan tepat waktu	100% data indikator terkumpul dan terdokumentasi dengan lengkap	
	d. Membuat laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	Menyediakan informasi komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan geriatri	Semua unit terkait pelayanan geriatri	Penyusunan laporan program	1 laporan setiap bulan	Tersusunnya laporan pelayanan geriatri	
	e. Memberikan feedback kepada unit terkait (Melalui rakor)	Menyampaikan hasil pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan geriatri kepada unit terkait	Tim geriatri	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala	100% hasil pengukuran dan analisis disampaikan kepada unit	



5	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi program PKRS untuk Geriatri						
	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri mengukur capaian Edukasi individu dan kelompok tentang : 1) Nutrisi lansia	Meningkatkan status gizi pasien lansia melalui pelayanan nutrisi yang tepat, aman, dan terintegrasi.	Seluruh pasien lansia	Asesmen gizi komprehensif oleh ahli gizi.	100% pasien lansia dilakukan skrining gizi dalam ≤24 jam	Kepuasan pasien/keluarga terhadap pelayanan nutrisi	
	2) Upaya perawatan lansia	Mencegah terjadinya komplikasi pada pasien lansia	Seluruh pasien lansia	Skrining geriatri awal (risiko jatuh, status fungsional, kognitif, nutrisi).	100% pasien lansia dilakukan skrining awal dalam ≤24 jam sejak masuk	Penurunan angka kejadian jatuh pada pasien lansia	
	3) PHBS	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat pada pasien, keluarga, pengunjung, dan petugas rumah sakit.	Pasien, keluarga, seluruh tenaga kesehatan	- Edukasi PHBS (cuci tangan, etika batuk, kebersihan diri, penggunaan APD) - Penyediaan sarana PHBS (handrub, wastafel,	100% unit pelayanan memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai.	- Persentase kepatuhan cuci tangan tenaga kesehatan ≥100%. - Penurunan angka kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) - Persentase ketersediaan	



				sabun, tempat sampah terpilah).		sarana PHBS $\geq 100\%$.	
	a. Melakukan pembinaan komunitas F-Kul						
	1) Untuk aktivitas fisik (Senam Lansia, Yoga Lansia) dan Bimroh (pengajian Sirrotul Jannnah).	Meningkatkan kebugaran fisik dan mempertahankan kemampuan fungsional lansia.	Pasien lansia dalam kondisi stabil	Senam lansia terstruktur	$\geq 80\%$ pasien lansia yang memenuhi syarat mengikuti senam lansia dan yoga lansia	Kepuasan peserta $\geq 100\%$.	
	b. Membuat Laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	Menyediakan informasi komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan geriatri	Semua unit terkait pelayanan geriatri	Penyusunan laporan program	1 laporan setiap bulan	Tersusunnya laporan pelayanan geriatri	
	e. Memberikan feedback kepada unit terkait (Melalui rakor)	Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui penyampaian umpan balik	Seluruh unit pelayanan di rumah sakit	Penyampaian feedback hasil monitoring dan evaluasi (monev)	100% hasil monitoring, audit, dan evaluasi disampaikan kepada unit terkait	Terjadi peningkatan capaian indikator mutu unit	

3.3 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 3.3.1 cara melaksanakan kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Membuat perencanaan dan revisi regulasi						
	a. Melakukan review Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat)	1) Menetapkan tim review (Tim Geriatri/Tim PMKP) 2) Mengumpulkan dokumen pedoman pelayanan geriatri yang berlaku 3) Mengidentifikasi regulasi terbaru 4) Membahas kesesuaian pedoman dengan standar akreditasi dan Permenkes 5) Pengesahan oleh pimpinan rumah sakit	Diskusi kelompok	Dokumen pedoman pelayanan geriatri	Dilaksanakan sesuai kebutuhan	SK pengesahan pedoman yang telah direvisi	
	b. Melakukan revisi Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat)	1) Membentuk tim geriatri 2) Mengidentifikasi pedoman lama yang perlu diperbarui 3) Melaksanakan rapat pembahasan draft bersama tim. 4) Melakukan perbaikan berdasarkan hasil rapat	Rapat	Dokumen	Rapat tim geriatri 1 januari 2026	Rapat tim geratri	
	c. Membuat Pedoman Kerja Tim Geriatri (Melalui rapat)	1) Menetapkan pembentukan Tim Penyusun Pedoman Kerja Tim Geriatri.	Rapat	Dokumen	Rapat tim geriatri 1 januari 2026	Rapat tim geratri	



		2) Menyusun draft Pedoman Kerja Tim Geriatri 3) Melaksanakan rapat pembahasan draft pedoman bersama tim 4) Melakukan sosialisasi pedoman kepada seluruh anggota tim dan unit terkait.					
	d. Membuat Program Kerja Pelayanan Tim Geriatri tahun 2026 (Melalui rapat)	1) Menetapkan pembentukan Tim Penyusun Program Kerja Tim Geriatri. 2) Menyusun draft Program Kerja Tim Geriatri 3) Melaksanakan rapat pembahasan draft program bersama tim 4) Melakukan sosialisasi program kepada seluruh anggota tim dan unit terkait.	Rapat	Dokumen	Rapat tim geriatri 1 januari 2026	Rapat tim geriatri	
	e. Merevisi SPO terkait Geriatri (Melalui rapat)	Membuat SPO	Rapat	Dokumen	Rapat tim geriatri 1 januari 2026	Rapat tim geriatri	
2	Peningkatan kompetensi SDM						
	a. Melaksanakan Diklat untuk Tim Geriatri	1) Menetapkan kebutuhan pelatihan berdasarkan standar akreditasi dan regulasi Permenkes terkait pelayanan geriatri	Diskusi	Materi pelatihan	26-27 januari 2026	Dokumen pelatihan	
	b. Sosialisasi prosedur pelayanan geriatri	Melaksanakan kegiatan sosialisasi prosedur pelayanan geriatri	Diskusi	Dokumen	Setiap hari	Simrs	



	c. Pelatihan pencegahan risiko jatuh	Meaksanakan pelatihan pencegahan resiko jatuh	Diskusi	Dokumen	Internal	Materi pelatihan	
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan klinik						
	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri :						
	Supervisi RM asuhan geriatri /kelengkapan dari: 1) Form Skrining geriatri di IGD, rawat inap, rawat jalan	Form skrining geratri di igd, rawat inap, dan rawat jalan	Komputer	Simrs	Di simrs	Simrs	
	2) Form Pengkajian awal keperawatan pada point Assemen geriatri	Form Pengkajian awal keperawatan pada point Assemen geriatri	Komputer	Simrs	Di simrs	Simrs	
	3) Form Discharge Planning	Form Discharge Planning	Komputer	Simrs	Di simrs	Simrs	



	4) Form Edukasi	Form edukasi	Komputer	Simrs	Di simrs	Simrs	
	5) Form RPP/RM (rujukan edukasi....)	Form rujukan	Komputer	Simrs	Di simrs	Simrs	
	6) Mengumpul kan data pencapaian kunjungan geriatri Irja, Irna, rujuk, meninggal, PRB, 10 besar penyakit Geriatri, demografi geriatri (lihat di pengkajian kebutuhan edukasi: usia, pekerjaan, pendidikan, keyakinan, hambatan)	Data tercantum di laporan bulanan dan triwulan	Komputer	Data rs	Pembuatan data setiap bulan	Data rs	
	7) Home visite dan Home Care	1) Identifikasi sasaran/px 2) Rencana kunjungan	Wawancara , pemeriksaan fisik	Leaflet, alat kesehatan	1x/bulan	Dokumentasi	



	8) Membuat laporan (bulanan, triwulan, tahunan) (dalam laporan harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL sesuai tata naskah)	1) Mengumpulan data 2) Menyusun laporan	Analisa data	Komputer	1 bulan sekali untuk laporan bulanan, dan 3 bulan sekali untuk triwulan	Laporan	
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan geriatri						
	a. Membuat Daftar Indikator Mutu geriatri	1. Menetapkan pembentukan Tim 2. Menetapkan tujuan 3. Mengidentifikasi area klinis prioritas 4. Menyusun indikator mutu	Literature riev dan Fokus group diskusi,	SK, SIMRS, Slide PPT	1 bulan sekali untuk laporan bulanan, dan 3 bulan sekali untuk triwulan	Laporan dan dokumentasi	
	b. Membuat Profil Indikator mutu Geriatri	1. Mengidentifikasi indikator prioritas 2. Menyusun profil indikator	Literature riev dan Fokus group diskusi,	Komputer dan buku pedoman geriatric	1-2 bulan	Laporan dan dokumentasi	



	c. Melakukan pengukuran mutu geriatri	1. Mengumpulkan data 2. Mengelola dan menganalisis data	Monitoring indicator mutu	Form indicator	Dilaksanakan sesuai kebutuhan	Laporan dan dokumentasi	
	d. Membuat laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	1. Menyusun struktur laporan 2. Menyajikan data 3. Membuat grafik	Analisa data	SIMRS	1 bulan	Dokumentasi	
	e. Memberikan feedback kepada unit terkait ((Melalui rakor)	1. Melaksanakan rapat koordinasi 2. Menindaklanjuti hasil rapat	Diskusi dan presentasi	PPT dan form RTL	1 bulan sekali untuk laporan bulanan, dan 3 bulan sekali untuk triwulan	Laporan dan dokumentasi	
5	Melakukan pemantauan dan evaluasi program PKRS untuk geriatri						
	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri mengukur capaian Edukasi individu dan kelompok tentang : 1) Nutrisi lansia	1. Mengumpulkan data 2. Mengukur pencapaian 3. Menganalisa data	Observasi	Leaflet	1 bulan	Laporan dan dokumentasi	
	2) Upaya perawatan lansia	1. Mengumpulkan data 2. Menganalisa dan evaluasi data	Observasi	Leaflet	1 bulan	Laporan dan dokumentasi	



	3) PHBS	1. Mengumpulkan data 2. Menganalisa dan evaluasi data	Observasi	Leaflet	1 bulan	Laporan dan dokumentasi	
	4) Risiko jatuh/ Manrisk	1. Mengumpulkan data 2. Menganalisa dan evaluasi data	Observasi	Leaflet	1 bulan	Laporan dan dokumentasi	
	b. Melakukan pembinaan komunitas F-Kul 1) Untuk aktivitas fisik (Senam Lansia, Yoga Lansia) dan Bimroh (pengajian Sirrotul Jannnah).	1. Mengumpulkan data 2. Menganalisa dan evaluasi data	Observasi	Leaflet	1 bulan	Laporan dan dokumentasi	
	c. Membuat Laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	1. Mengumpulkan data 2. Menyusun laporan 3. Mengevaluasi pelaporan	Observasi	Komputer	1 bulan	Dokumentasi	
	d. Memberikan feedback kepada unit terkait (Melalui rakor)	1. Mengumpulkan dan mengelola data 2. Mengevaluasi dan tindak lanjut	Analisis data	Data rekapitulasi	1 bulan sekali untuk laporan bulanan, dan 3 bulan sekali untuk triwulan	Laporan dan dokumentasi	

f. JADWAL MELAKSANAKAN KEGIATAN
Tabel 3.4.1 jadwal pelaksanaan geriatric

No	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA		
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
1	Membuat perencanaan dan revisi regulasi																		
	a. Melakukan review pedoman pelayanan geriatri (melalui rapat)	1) Tersusunnya pedoman pelayanan geriatri yang sesuai dengan standar akreditasi dan regulasi Permenkes terbaru		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
	b. Melakukan revisi pedoman pelayanan geriatri (melalui rapat)	1) Merevisi pedoman pelayanan geriatri yang sesuai dengan standar akreditasi dan regulasi Permenkes terbaru		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	c. Membuat pedoman kerja tim geriatri (melalui rapat)	1) Tersusunnya pedoman kerja geriatri yang sesuai dengan standar akreditasi dan regulasi Permenkes terbaru		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	d. Membuat program kerja pelayanan tim geriatri tahun 2026 (melalui rapat)	1) Tersusunnya program kerja pelayanan geriatri yang sesuai dengan standar akreditasi dan regulasi Permenkes terbaru		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	e. Merevisi SPO terkait Geriatri (Melalui rapat)	1) Tersusunnya SPO pelayanan geriatri		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang



		2) Tersedia nya dokumen SPO																	
2	Peningkatan Kompetensi SDM																		
	a. Melaksanakan Diklat untuk Tim Geriatri	1) Meningkatnya kompetensi dan keterampilan Tim Geriatri dalam memberikan pelayanan sesuai standar akreditasi dan Permenkes		√													IGD/IRJA/IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	b. Sosialisasi prosedur pelayanan geriatri	1) Meningkatnya pemahaman tenaga kesehatan dan unit terkait terhadap prosedur pelayanan geriatri sesuai standar akreditasi dan Permenkes		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	c. Pelatihan pencegahan risiko jatuh	1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko jatuh pada pasien, khususnya lansia		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Klinis																		RS Prima Husada Malang



a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri : Supervisi RM asuhan geriatri /kelengkapan dari:																IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
1) Form Skrining geriatri di IGD, rawat inap, rawat jalan	Tersedianya form skrining geriatri di seluruh unit pelayanan (IGD, rawat inap, rawat jalan)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
2) Form Pengkajian awal keperawatan pada point Assemen geriatri	Tersedianya form pengkajian awal keperawatan pada point Assemen geriatic		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
3) Form discharge planning	Tersedianya form discharge planning		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
4) Form edukasi	Tersedia nya form edukasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
5) Form RPP/RM (rujukan edukasi....)	Tersedianya form RPP/RM (rujukan edukasi....)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRJA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang



6)	Mengumpulkan data pencapaian kunjungan geriatric Irja, Irna, rujuk, meninggal, PRB, 10 besar penyakit Geriatri, demografi geriatri (lihat di pengkajian kebutuhan edukasi: usia, pekerjaan, pendidikan, keyakinan, hambatan)	Tersedianya data pelayanan geriatri yang lengkap, akurat, dan terintegrasi dari unit rawat jalan (IRJA), rawat inap (IRNA), rujukan, dan pelayanan lainnya		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRJA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
7)	Home visite dan Home Care	Terlaksananya pelayanan home visit dan home care geriatri		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Home care	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
8)	Membuat laporan (bulanan, triwulan, tahunan) (dalam laporan harus ada narasi, tabulasi, kalua	1) Tersusunnya laporan pelayanan geriatri yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai standar akreditasi dan Permenkes 2) Terlaksananya proses pelaporan secara rutin, sistematis, dan berkelanjutan			√			√			√			√		Ruang Rapat	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang



	perlu grafik, analisis, RTL sesuai tata naskah)																	
4	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan Geriatri																Ruang Rapat	
	a. Membuat Daftar Indikator Mutu geriatri	Tersusunnya daftar indikator mutu terdiri dari 1) Lama rawat inap 2) Status fungsional 3) Kualitas hidup 4) Rawat inap ulang 5) Kepuasan pasien		√													Ruang Rapat	Tim geriatric RS Prima Husada Malang
	a. Membuat Profil Indikator mutu Geriatri	Tersusunnya daftar indikator mutu terdiri dari 1) Lama rawat inap 2) Status fungsional 3) Kualitas hidup 4) Rawat inap ulang 5) Kepuasan pasien		√													IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric RS Prima Husada Malang
	b. Melakukan pengukuran mutu geriatri	Tersusunnya daftar indikator mutu terdapat di laporan triwulan		√													Ruang Rapat	Tim geriatric RS Prima Husada Malang
	c. Membuat laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	1) Tersusunnya laporan pelayanan geriatri yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai standar akreditasi dan Permenkes		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Ruang Rapat	Tim geriatric RS Prima Husada Malang



		2) Terlaksananya proses pelaporan secara rutin, sistematis, dan berkelanjutan																
5	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi program PKRS untuk Geriatri																	
	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri mengukur capaian Edukasi individu dan kelompok tetang : 1) Nutrisi lansia	Terlaksananya pemantauan edukasi nutrisi lansia secara rutin dan terstruktur pada pelayanan individu dan kelompok		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA, GIZI	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	2) Upaya perawatan lansia	Terlaksananya pemantauan edukasi Upaya perawatan lansia secara rutin dan terstruktur pada pelayanan individu dan kelompok		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA,	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	3) PHBS	Terlaksananya pemantauan edukasi Upaya perawatan lansia secara rutin dan terstruktur pada pelayanan individu dan kelompok		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
	4) Resiko jatuh/Manrisk	Terlaksananya identifikasi dan skrining risiko jatuh pada seluruh pasien geriatri secara rutin dan sistematis														IGD, IRJA, IRNA	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang



b. Melakukan pembinaan komunitas FKUL 1) Untuk aktivitas fisik (Senam Lansia, Yoga Lansia) dan Bimroh (pengajian Sirrotul Jannnah).	Teraksananya senam lansia dan kajian shirotul jannah		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Area Halaman Parkiran dan Masjid Baiturrahim	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang
c. Membuat Laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	1) Tersusunnya laporan pelayanan geriatri yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai standar akreditasi dan Permenkes 2) Terlaksananya proses pelaporan secara rutin, sistematis, dan berkelanjutan				√			√			√			√	Ruang Rapat	Tim geriatric	RS Prima Husada Malang

3.1 KEBUTUHAN ANGGARAN

Tabel 3.5.1 Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JENIS	KEBUTUHAN SATU TAHUN	HARGA SATUAN	TOTAL ANGGARAN
1	Membuat perencanaan dan revisi regulasi					
	a. Melakukan review Pedoman pelayanan geriatric (Melalui rapat)	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-



	b. Melakukan revisi Pedoman pelayanan geriatri (Melalui rapat)	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	c. Membuat Pedoman Kerja Tim Geriatri (Melalui rapat)	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	d. Membuat Program Kerja Tim Geriatri tahun 2026 (Melalui rapat)	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	e. Merevisi SPO terkait Geriatri (Melalui rapat)	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
2	Peningkatan Kompetensi SDM					
	a. Melaksanakan Diklat untuk Tim Geriatri	Persiapan diklat	Pelatihan	1x/tahun	Eksternal mandiri	Rp,0-
	b. Sosialisasi prosedur pelayanan geriatri	Materi sosialisasi di simrs	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	c. Pelatihan pencegahan risiko jatuh	Pelatihan pencegahan resiko jatuh	Dokumen	1x/tahun	Rp,500,000-	Rp,500.000-
3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Klinis					
	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri : Supervisi RM asuhan geriatri /kelengkapan dari: 1) Form Skrining geriatri di IGD, rawat inap, rawat jalan	Form skrining terdapat di simrs	Dokumen	Setiap hari	Rp,0-	Rp,0-
	2) Form Pengkajian awal keperawatan	Form pengkajian terdapat di simrs	Dokumen	Setiap hari	Rp,0-	Rp,0-



	pada point Assemen geriatric					
	3) Form discharge planning	Form discharge planning terdapat di simrs	Dokumen	Setiap hari	Rp,0-	Rp,0-
	4) Form edukasi	Form edukasi terdapat di simrs	Dokumen	Setiap hari	Rp,0-	Rp,0-
	5) Form RPP/RM (rujukan edukasi....)	Form RPP terdapat di simrs	Dokumen	Setiap hari	Rp,0-	Rp,0-
	6) Mengumpulkan data pencapaian kunjungan geriatric Irja, Irna, rujuk, meninggal, PRB, 10 besar penyakit Geriatri, demografi geriatri (lihat di pengkajian kebutuhan edukasi: usia, pekerjaan, pendidikan, keyakinan, hambatan)	Form terdapat di simrs	Dokumen	Setiap hari	Rp,0-	Rp,0-
	7) Home visite dan Home Care	1) Penyusunan/penjadwalan px 2) Paksanaan kunjungan rumah	Kunjungan rumah	Minimal 1bulan 1x	Rp,50.000-	Rp,50.000-
	8) Membuat laporan (bulanan, triwulan, tahunan) (dalam laporan harus ada narasi, tabulasi, kalua perlu grafik, analisis, RTL sesuai tata naskah)	1) Pengumpulan data 2) Penyusunan laporan	Dokumen	Simrs	Rp,0-	Rp,0-



4	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan Geriatri					
	a. Membuat Daftar Indikator Mutu geriatri	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	b. Membuat Profil Indikator mutu Geriatri	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	c. Melakukan pengukuran mutu geriatri	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-
	d. Membuat laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL	1) Pengumpulan data 2) Penyusunan laporan	Dokumen	1 bulan/sekali	Rp,0-	Rp,0-
5	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi program PKRS untuk Geriatri					
	a. Melakukan Pemantauan pelayanan geriatri mengukur capaian Edukasi individu dan kelompok tetang : 1) Nutrisi lansia	Edukasi nutrisi lansia	Leaflet	Setap pasien masuk	Rp,1500/orang	Rp,1500/orang
	2) Upaya perawatan lansia	Edukasi perawatan lansia	Leaflet	Setap pasien masuk	Rp,1500/orang	Rp,1500/orang
	3) PHBS	Edukasi PHBS pasien lansia di rumah	Leaflet	Setap pasien masuk	Rp,1500/orang	Rp,1500/orang
	4) Resiko jatuh/ Manrisk	Edukasi resiko jatuh	Leaflet	Setap pasien masuk	Rp,1500/orang	Rp,1500/orang
	b. Melakukan pembinaan komunitas F-Kul 1) Untuk aktivitas fisik (Senam Lansia, Yoga Lansia) dan Bimroh	1) Dilakukan senam lansia setiap hari jumat 2) Dilakukan pengajian shirotul jannah setiap 1bulan sekali	Leflet dan petugas senam	1) Senam setiap hari jumat dan yoga setiap hari sabtu	Rp,100.000-	Rp,100.00-



	(pengajian Sirrotul Jannnah).			2) Pengajian sebulan/2 kali		
	c. Membuat Laporan (harus ada narasi, tabulasi, kalau perlu grafik, analisis, RTL)	1) Persiapan rapat 2) Dokumen	Dokumen	1x/tahun	Rp,0-	Rp,0-



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 MONITORING

1. Tujuan
 - a. Memastikan pelaksanaan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra).
 - b. Menjamin kepatuhan terhadap standar akreditasi dan regulasi Kemenkes.
 - c. Mengukur capaian indikator mutu dan keselamatan pasien.
 - d. Mengidentifikasi risiko dan hambatan.
 - e. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berbasis data
2. Ruang Lingkup Monitoring
 - a. Pelayanan Medis & Keperawatan
 - b. PMKP (Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien)
 - c. PPI (Pencegahan & Pengendalian Infeksi)
 - d. Manajemen Risiko
 - e. SDM & Kredensial
 - f. Sarana Prasarana & K3RS
 - g. Manajemen Rekam Medis
 - h. Keuangan & Administrasi
3. Metode Monitoring
 - a. Audit Internal Berkala
 - b. Monitoring Indikator Mutu
 - c. Telaah Rekam Medis
 - d. Observasi Lapangan
 - e. Survey Kepuasan Pasien

4.2 EVALUASI

1. Tujuan
 - a. Menilai capaian indikator kinerja dan mutu.
 - b. Mengukur efektivitas program kerja unit dan manajemen.
 - c. Mengidentifikasi hambatan dan risiko.
 - d. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - e. Menjadi bukti objektif dalam survei akreditasi dan audit internal.
2. Metodologi Evaluasi
 - a. Analisis capaian indikator (triwulan & tahunan)
 - b. Audit internal & telaah dokumen
 - c. Review laporan insiden keselamatan pasien
 - d. Survey kepuasan pasien
 - e. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
3. Prosedur evaluasi
 - a. Pengumpulan data
 - 1) Mengumpulkan seluruh laporan monitoring bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan.
 - 2) Mengumpulkan indikator mutu dan keselamatan pasien yang terkait layanan keperawatan
 - 3) Mengumpulkan laporan kegiatan sub komite
 - b. Verifikasi kebenaran data
 - 1) Analisis pelaksanaan program
 - 2) Membandingkan realisasi program kerja dengan rencana tahunan
 - 3) Menilai tingkat capaian (% target tercapai)
 - 4) Menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar akreditasi dan permenkes



-
- 5) Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala dan risiko
 - c. Penilaian efektifitas program
 - 1) Menilai manfaat program terhadap peningkatan mutu
 - 2) Menilai dampak terhadap keamanan pasien dan praktik profesional
 - d. Penetapan temuan evaluasi
Klasifikasi temuan:
 - 1) Kritis : berdampak pada keselamatan pasien/ etik/ disiplin
 - 2) Mayor : pelanggaran signifikan terhadap SPO/ standar
 - 3) Minor : ketidaksesuaian yang tidak berdampak langsung
 - e. Penyusunan rekomendasi
 - 1) Membuat rekomendasi perbaikan spesifik dan terukur
 - 2) Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan risiko
 - 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, revisi SPO atau perubahan prosedur



BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 PENCATATAN

1. Semua kegiatan Geriatri dicatat sesuai jenis kegiatan dan SPO nya.
2. Laporan disusun berdasarkan laporan dari unit kerja dan setiap 3 bulan Tim Geriatri melaporkan kegiatan ke Direktur

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Petugas
1.	Pembuatan laporan triwulan	Pertanggung jawaban kepada Direktur	Laporan Triwulan	Ketua dibantu sekretaris
2.	Monitoring kegiatan Tim Geriatri (senam lansia, yoga lansia, kegiatan rohani, posyandu lansia dan home care)	Memantau proses kegiatan yang sedang berlangsung	Anggota Tim Geriatri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya	Tim Geriatri
3.	Monitoring pelayanan geriatri (rawat jalan dan rawat inap)	Memantau proses pelayanan di unit	Anggota Tim Geriatri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya	Tim Geriatri

5.2 PELAPORAN

1. Evaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh dilakukan melalui rapat Tim Geriatri setiap 3 bulan sekali.

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Petugas
1.	Rapat bulanan sebagai evaluasi kegiatan	Evaluasi program bulanan Membahas masalah yang ada Mencari solusi	Program geriatri dilaksanakan Laporan bulanan tepat waktu	Ketua dibantu sekretaris Anggota Tim Geriatri
2.	Rapat koordinasi Tim Geriatri	Evaluasi terkait pelayanan dan program geriatri	Pelayanan dan program geriatri dilaksanakan Laporan bulanan tepat waktu	Ketua dibantu sekretaris Anggota Tim Geriatri



BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Program Kerja Geriatri Tingkat Lengkap di Rumah Sakit Prima Husada merupakan wujud komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan bagi pasien lanjut usia. Program ini disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, serta standar akreditasi nasional yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Demikian Program Kerja Geriatri ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama periode yang telah ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan senantiasa dilakukan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program

Malang, 01 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Ketua Geriatri

dr. Heriyatmo, Sp.PD

Form skrining IGD, Ranap, Rajal

PENGKAJIAN RISIKO JATUH PASIEN GERIATRI

ONTARIO MODIFIED STRATIFY - SYDNEY SCORING

No.	Parameter	Skrining	Kajian Awal	Kajian Ulang			
				2026-06-11			
1	Riwayat Jatuh	Apakah Pasien Datang Ke Rumah Sakit Karena Jatuh?	0	0			
2		Jika Tidak, Apakah Pasien Mengalami Jatuh Dalam 2 Bulan Terakhir Ini?	0	0			
3	Status Mental	Apakah Pasien Delirium? (Tidak Dapat Membuat Keputusan, Pola Pikir Tidak Terorganisir, Gangguan Daya Ingat)	0	0			
4		Apakah Pasien Disorientasi? (Salah Menyebutkan Waktu, Tempat, Atau Orang)	0	0			
5		Apakah Pasien Mengalami Agitasi? (Ketakutan, Gelisah, Dan Cemas)	0	0			
6	Penglihatan	Apakah Pasien Memakai Kacamata?	0	0			
7		Apakah Pasien Mengeluh Adanya Penglihatan Buram?	0	0			
8		Apakah Pasien Mempunyai Glaukoma, Katarak, Atau Degenerasi Makula?	0	0			
9	Kebiasaan Berkemih	Apakah Terdapat Perubahan Perilaku Berkemih? (Frekuensi, Urgensi, Inkontinensia, Nokturia)	0	0			
10	Transfer (Dari Tempat Tidur Ke Kursi Dan Kembali Ke Tempat Tidur)	Mandiri (Boleh Menggunakan Alat Bantu Jalan)	0	0			
11		Memerlukan Sedikit Bantuan (1 Orang) / Dalam Pengawasan	0	1			
12		Memerlukan Bantuan Yang Nyata (2 Orang)	0	0			
13		Tidak Dapat Duduk Dengan Seimbang, Perlu Bantuan Total	0	0			
14	Mobilitas	Mandiri (Boleh Menggunakan Alat Bantu Jalan)	0	0			
15		Berjalan Dg Bantuan 1 Orang (Verbal / Fisik)	0	1			
16		Menggunakan Kursi Roda	0	0			
17		Imobilisasi	0	0			
Total Skor			0	2	0	0	0

Total Skor 0 2 0 0 0 0

Daftar Obat-Obatan (Tandai Obat-Obatan Yang Dikonsumsi Pasien):

Satu Atau Lebih Penggunaan Obat-Obatan Di Bawah Ini Dapat Meningkatkan Risiko Jatuh:

- | | |
|---|--|
| ☐ Antihipertensi | ☐ Antikonvulsan |
| ☐ Benzodiazepine | ☐ Pencahar |
| ☐ Antiparkinson | ☐ Psikotropika |
| ☐ Opioid | ☐ Diuretik |
| ☐ Hipoglikemia | |

Langkah-langkah Intervensi

No.	Intervensi	Kajian Awal	Kajian Ulang			
			11/06/2026			
1	Orientasi kamar tidur dan lingkungan rawat inap, beserta staf rumah sakit	X	X			
2	Posisikan tempat tidur pasien rendah. Pastikan rem tempat tidur berfungsi dengan baik	X	X			
3	Alarm, tombol pemanggil, dan meja samping dapat dijangkau tangan pasien, intruksikan pasien untuk memanggil bantuan jika memerlukan sesuatu	X	X			
4	Pastikan penggunaan alas kaki yang aman saat mobilisasi	X	X			
5	Sediakan brosur pemakaian alas kaki yang aman kepada pasien dan keluarga	X	X			

1

6	Pakaian pasien berukuran pas (tidak terlalu besar / kecil)	X	X			
7	Amankan area dari perabot yang tidak stabil, ruangan yang berantakan	X	X			
8	Sediakan brosur pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarga	X	X			
9	Pastikan pasien memperoleh nutrisi dan hidrasi yang adekuat	X	X			
10	Peninjauan obat-obatan	X				
11	Obat-obatan untuk proteksi tulang: pertimbangkan suplementasi vitamin D dan kalsium	X	X			
12	Pastikan pasien memakai kacamata dan alat bantu dengar (jika diperlukan)					
13	Pasang stiker kuning pada gelang pasien					
14	Pasang tanda risiko jatuh pada tempat tidur					

14	Pasang tanda risiko jatuh pada tempat tidur						
15	Awasi pasien saat mobilisasi						
16	Awasi pasien saat menggunakan kamar mandi						
17	Pantau nutrisi dan hidrasi pasien						
18	Gunakan karpet anti-licin di dekat tempat tidur						
19	Rujuk ke fisioterapi dan atau okupasional terapi untuk asesmen lebih lanjut						
20	Jangan tinggalkan pasien tanpa pengawasan saat di kamar mandi atau mobilisasi						
21	Tempatkan kamar tidur pasien dekat dengan nurse station						
22	Pastikan tinggi tempat tidur sesuai dengan kebutuhan pasien						
23	Pertimbangkan observasi konstan - terutama jika pasien delirium						
24	Pertimbangkan penunaan protektor panggul						

Pelayanan Rawat Inap

ASIKAH

No. RM Tgl. Lahir/Umur
250541 01/01/1943 (83th 5bln 9hr) Perempuan

Jenis Kelamin

Belum Ada Foto

No. Reg Tgl. MRS
RI2606100028 10/06/2026 08:43

Nama Dokter
dr. Heriyatmo Sp. PD

Status Tgl. KRS
Belum Keluar

Cara Bayar
BPJS KESEHATAN

No. Kartu
0000784839475

No. Jaminan/SEP
0187R0130626V003780

Alergi

Alergen Keterangan

<No d

Ketik disini untuk mencari menu...

Dokter

Data Dokter Pasien

Pengkajian Awal Medis

CPT

Resep

Konsultasi Dokter

Pneumonia Severity Index (PSI)

Score Dehidrasi

Laporan Pungsi

Penunjang

Laboratorium

Radiologi

Penunjang Lain

Perawat/Bidan

SBAR

Ruang Perawatan

Transfer Pasien

Pengkajian Awal Keperawatan

Asuhan Keperawatan Pre Operasi

Pengkajian Keperawatan Neonatus

Pengkajian Fisioterapi

Asuhan Keperawatan/Kebidanan

Pengkajian Resiko Jatuh

Pengkajian Ulang Nyeri

Pengkajian Nyeri Nipples

Observasi Inpartu

Pengkajian IGD/ Rawat Jalan

Pengkajian Awal Medis

Pengkajian Awal Keperawatan

Pengkajian Resiko Jatuh

PENGKAJIAN AWAL KEPERAWATAN/KEBIDANAN

Tanggal: 10/06/2026 13:45

Dokter Pemeriksa: dr. Yolanda Alfichasari

DPJP: dr. Heriyatmo Sp. PD

Diagnosa Masuk: GEA

Anamnesis

Riwayat Penyakit

Status Biologi

Pemeriksaan Fisik

Skining Nyeri

Risiko Jatuh

Skining Gizi

Dx. Keperawatan

KIE

Pengkajian Resiko Jatuh Pasien Geratri

No.	Parameter	Skining	Jawab
1.	Riwayat Jatuh	Apakah Pasien Datang Ke Rumah Sakit Karena Jatuh?	Tidak
		Jika Tidak, Apakah Pasien Mengalami Jatuh Dalam 2 Bulan Terakhir ini?	Tidak
2.	Status Mental	Apakah Pasien Delirium? (Tidak Dapat Membuat Keputusan, Pola Pikir Tidak Terorganisir, Gangguan Daya Ingat)	Ya
		Apakah Pasien Disorientasi? (Salah Menyebutkan Waktu, Tempat, atau Orang)	Tidak
		Apakah Pasien Mengalami Agitasi? (Ketakutan, Gelasah, Dan Cemas)	Tidak
3.	Penglihatan	Apakah Pasien Menggunakan Kacamata?	Tidak
		Apakah Pasien Mengeluh Adanya Penglihatan Buram?	Ya
		Apakah Pasien Mempunyai Glaukoma, Katarak, Atau Degenerasi Makula?	Ya
4.	Kebiasaan Berkemih	Apakah Terdapat Perubahan Perilaku Berkemih? (Frekuensi, Urgensi, Inkontinensi, Nokturia)	Ya
5.	Transfer (Dari Tempat Kursi Dan Kembali Ke Tempat Tidur)	Memerlukan Sedikit Bantuan (1 Orang) / Dalam Pengawasan	
6.	Mobilitas	Berjalan Dengan Bantuan 1 Orang (Verbal/Fisik)	

Total Skor: 17

Kembali ke Daftar Pasien

Isa Ariyanti S. Kep.Ns (Perawat) on 172.1.240.39

Banjararum Selatan No. 3 – 7 Singosari – Malang

Telp : 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874 ; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



Form pengkajian awal keperawatan assasmen geriatri

Pengkajian Resiko Jatuh Pasien Geriatri					
No.	Parameter	Skrining	Jawab	Keterangan Nilai	Kajian Awal
1	Riwayat Jatuh	Apakah pasien datang ke rumah sakit karena jatuh ?	Ya / Tidak	Salah satu jawaban Ya = 6	Tidak
		Jika tidak, Apakah pasien mengalami jatuh dalam 2 bulan terakhir ini ?	Ya / Tidak		Tidak
2	Status Mental	Apakah Pasien Delirium? (Tidak Dapat Membuat Keputusan, Pola Pikir Tidak Terorganisir, Gangguan Daya Ingat)	Ya / Tidak	Salah satu jawaban Ya = 14	Ya
		Apakah Pasien Diorientasi? (Salah Menyebutkan Waktu, Tempat, atau Orang)	Ya / Tidak		Tidak
		Apakah Pasien Mengalami Agitasi? (Ketakutan, Gelisah, Dan Cemas)	Ya / Tidak		Tidak
3	Penglihatan	Apakah Pasien Menggunakan Kacamata?	Ya / Tidak	Salah satu jawaban Ya = 1	Tidak
		Apakah Pasien Mengeluh Adanya Penglihatan Buram?	Ya / Tidak		Ya
		Apakah Pasien Mempunyai Glaukoma, Katarak, Atau Degenerasi Makula?	Ya / Tidak		Ya
4	Kebiasaan Berkemih	Apakah Terdapat Perubahan Perilaku Berkemih? (Frekuensi, Urgensi, Inkontinensia, Nokturia)	Ya / Tidak	Ya = 2	Ya
5	Transfer (dari tempat tidur ke kursi dan kembali ke tempat tidur)	Mandiri (boleh menggunakan alat bantu jalan)	0	Jumlahkan nilai transfer dan mobilitas. Jika Nilai total 0-3 Skor=0, Jika Nilai total 4-6 Skor=7	0
		Memerlukan sedikit bantuan (1 orang) / dalam pengawasan	1		
		Memerlukan bantuan yang nyata (2 orang)	2		
		Tidak dapat duduk dengan seimbang, perlu bantuan total	3		
6	Mobilitas	Mandiri (boleh menggunakan alat bantu jalan)	0		0
		Berjalan dengan bantuan 1 orang (verbal/fisik)	1		
		Menggunakan kursi roda	2		
		Imobilisasi	3		
Total Skor					17



Form discharge planning

DISCHARGE PLANNING CHECKLIST

Kelas / Kamar	I / HCU 1
Nama Pasien	HARJONO
Tanggal Lahir	09/03/1946
Tanggal Masuk	09/06/2026 Jam: 16:06 WIB
Agama	Islam
Alamat	PERUM VALENSIA BLOK B7/5 RT. 07 RW. 14 KEL. SAPTORENGGO Kec. PAKIS KAB MALANG JAWA TIMUR
DPJP utama	dr. Yoga Waranugraha Sp. JP (K)
Dokter rawat bersama	
Diagnosis	Utama: Mitral Insufficiency Sekunder: Bradicardia Sekunder: Chronic Ischemic Heart Disease Sekunder: Cardiogenic shock

Discharge Risk Assessment	
Pasien tinggal di rumah dengan support komunitas terbatas atau tinggal sendiri	☐
Membutuhkan bantuan untuk manajemen pengobatan	☒
Polifarmasi (lebih dari 7 macam obat)	☒
Membutuhkan diet khusus	☒
Terpasang alat medis (NGT, Kateter Urine, CVC, Colostomy Bag, Drain, Lainnya)	☐
Luka akut/kronis/decubitus	☐
Membutuhkan bantuan untuk manajemen oksigen/nebulizer	☐
Membutuhkan bantuan untuk Activity Daily Living	☒
Penurunan kognitif	☐
Riwayat gangguan mental	☐
Diagnosa pasien CHF, DM, COPD, HIV-AIDS	☒
Inkontinensia	☐
Kondisi terminal (end stage disease)	☐
Riwayat jatuh	☐
Ketidakpatuhan terhadap rencana medis	☐
Rawat inap / kunjungan ke IGD berulang	☒
Riwayat jatuh	☐
Ketidakpatuhan terhadap rencana medis	☐

1

Rawat inap / kunjungan ke IGD berulang	☒			
DICHARGE PLANNING				
KEGIATAN	CATATAN			
TANDA TANGAN				
				
RISMA INDRA SETIYANI S.KEP.NS				
DAFTAR OBAT - OBATAN				
NAMA OBAT	INDIKASI	DOSIS	CARA MINUM	WAKTU MINUM
CLOPIDOGREL TAB 75 MG - HEXPHARM JAYA - HEXPHARM JAYA		1-0-0	Oral	sesudah makan
ATORVASTATIN TAB 20 MG - OGB DEXA - OGB DEXA		0-0-1	Oral	sesudah makan
ALPRAZOLAM TAB 0.5 MG - MERSI		0-0-1	Oral	sesudah makan
TANDA TANGAN				
				
RISMA INDRA SETIYANI S.KEP.NS				
Telah dilakukan edukasi tentang DICHARGE PLANNING Rencana Pasien Pulang kepada :	Pasien	Keluarga	MPP	
☐ Pasien				
☒ Keluarga pasien, nama: Eingsen junaidah				
Hubungan dengan pasien: Anak				

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

FORMULIR PEMBERIAN EDUKASI

PENGKAJIAN KEBUTUHAN EDUKASI

www.rs-primahusada.com



KEBUTUHAN EDUKASI		TUJUAN	KEMAMPUAN BELAJAR	KESIAPAN BELAJAR
A. ADMISI 1. Hak dan Kewajiban keluarga 2. Status penjaminan dan cara bayar 3. Identifikasi kebutuhan pasien 4. Tata Tertib		1. Mulai menggunakan informasi yang didapat 2. Dapat mengungkapkan secara lisan informasi yang didapat	1. Dapat mengubah perilaku 2. Dapat menguasai informasi dan menjelaskan 3. Mampu menguasai informasi 4. Tidak jelas pada saat ini	1. Siap 2. Tertarik 3. Tidak tertarik/ tidak mampu
B. RENCANA ASUHAN 1. Diagnosis dan rencana asuhan 2 Terapi obat dan ESO 3 Diet dan Nutrisi 4 Manajemen nyeri 5 Risiko jatuh 6 Prosedur perawatan dan penggunaan alkes 7 Rencana keputungan 8 Teknik Rehabilitasi				
C. Edukasi lain-lain 1 PHBS (Hand hygiene, Etika batuk bersin, buang sampah, Protkes, rokok) 2. Penggunaan APD 3. Pencegahan penyakit 4. Lain-lain.....				

1

HAMBATAN	INTERVENSI TERHADAP HAMBATAN	METODE PEMBELAJARAN	MEDIA/ MATERI EDUKASI	Hasil
1. Tidak ada 2. Takut 3. Tidak tertarik 4. Nyeri/tidak nyaman 5. Gangguan kognitif 6. Hambatan bahasa	1. Tidak ada 2. Membatasi materi 3. Menggunakan penerjemah 4. Mengulangi edukasi 5. Mengedukasi	1. Diskusi/FGD 2. Ceramah, Tanya - jawab 3. Demonstrasi 4. Roll Play	1. Leaflet 2. Booklet 3. Lembar balik 4. Audiovisual 5. Audio 6. Lain-lain	1. Menunjukkan tingkat pengetahuan yang diharapkan (pasien/ keluarga paham) 2. Membutuhkan petunjuk tambahan (edukasi atau demo ulang)

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN EDUKASI TERINTERGRASI

Pelaksanaan Edukasi	Tanggal	Tujuan	Kemampuan Belajar	Hambatan	Intervensi	Metode	Material	No. Leaflet	Hasil	Verifikasi	Tgl. Re-edukasi	Tanda tangan		
												Petugas	Pasien/Keluarga	Verifikator
Hak dan Kewajiban keluarga	10/06/2026	1	3	1	1	2	1	UM/003.U M/008	1					
Status penjaminan dan cara bayar	10/06/2026	1	1	1	1	2	1	UM/003.U M/008	1					
Identifikasi kebutuhan pasien	10/06/2026	1	1	1	1	2	1	UM/003.U M/008	1					
Diagnosis dan rencana asuhan	10/06/2026	1	1	1	1	1	1		1	Sudah mengerti				
Identifikasi Pasien	10/06/2026	1	1	1	1	1	1		1	Sudah mengerti				
Orientasi ruangan kebersihan lingkungan	10/06/2026	1	1	1	1	1	1		1					

Asuhan farmasi penggunaan obat yang aman	11/06/2026	1	3	1	1	2	1	FM/002	1					
Interaksi obat & makanan	11/06/2026	1	3	1	1	2	1	FM/001	1					
Asuhan Gizi : Diet & Nutrisi														
Batasan diet – penyimpanan – cegah kontaminasi														
Pengelolaan nyeri														
Pencegahan Risiko jatuh	10/06/2026	1	1	1	1	1	1		1					
Perawatan dan penggunaan alat medis yang aman														

Rencana Kepulangan														
Teknik Rehabilitasi														
Hand hygiene														
Penggunaan APD														
Pencegahan penyakit														
Etika batuk-bersin	10/06/2026	1	1	1	1	1	1		1					
Protokol Kesehatan	10/06/2026	1	1	1	1	1	1		1					

PreOp Anestesi														
Pre-Op Penandaan														
EWS														
As. Menjelang akhir kehidupan pasien														
Setiap kali melakukan tindakan														
Rujukan Edukasi berkelanjutan kekomunitas / FKTP														
Rujuk balik ke FKTP														



Asuhan lanjutan dirumah														
Hasil Asuhan														



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		YAYUK SRI RAHAYU 24/02/1955 - 71th 3bin 15hr 212205 Jns. Kel : P		
FORMULIR RUJUK PASIEN ANTAR RUMAH SAKIT				
Identitas Pasien		Tujuan RS Rujukan		
Nama Pasien : YUKIE S. Rahayu No RM : 212205 Tanggal Lahir : 24/02/1955 Tanggal Masuk : 11/06/2026 Pukul 00 WIB Petugas Yang Kontak :	Kepada : PS7 Sayaboon Nama Faskes Rujukan : Bagian/ Nama Dokter : Staf Yang Menerima : Bagian: 705 Telepon :			
Diagnosis Kerja : ICH HT Emergency				
Alasan dirujuk : pro evaluasi tindakan				
Hasil Pemeriksaan				
Keluhan utama : Demam keadaman.				
Riwayat Penyakit : pasien datang dengan keluhan demam berkepanjangan sejak 1 jam sil. awalnya pusing sampai ke seluruh parts dan kadang partu badan setelah itu demam panas henti tidak ada ada karena sekejapnya.				
Riwayat Alergi : RPO 10 unguisidul, CUP merah 2004				
Pemeriksaan Fisik : TD: 120/80 mmHg Suhu 38°C K. N. N: 87/mnt RR: 20/mnt.				
Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan : lab ERG Ro Thromb CRisan lupus dan karies.				
Kebutuhan Pelayanan :				
☐ RI ☐ Isolasi ☐ Operasi ☐ ICU ☐ Kamar bersalin ☒ RPO avacua Hamman & Borden 2nd ed.				
Prosedur Dan Intervensi (Terapi Atau Tindakan Yang Telah Dilakukan)				
Tindakan :	☐ Pasang infus Nebul ☐ Injeksi Kateter No 16 ☐ Rawat luka Irigasi mata ☐ Hecting NGT 16 G ☐ Tindakan kegawatan			
Terapi : NO 10ml STAP 10mg/ml gr 1/2am (2-4). PO adalat 200 mg 3x 10g clonidine 2x 200mg (0.8) lisinopril 10 mg 1x metoprolol 2x 100mg (0.8) valproate 200 mg 3x parasetamol 3x 100mg (16.00) ketorolac 3x 30mg (12) diclofenak 1p 60mg (0.8) + sup				
Dokter Pengirim :				
Kategori Pendampingan Pasien Transfer				
Derajat	Petugas Pendamping (Minimal)	Nama Petugas Pendamping		
0	Petugas Ambulan			
0,5 Orang Tua/ Delirium	Petugas Ambulan Dan Paramedis			
1	Petugas Ambulan Dan Perawat	Rob Gunt / ma		
2	Dokter, Perawat, Petugas Ambulan			
3	Dokter, Perawat, Petugas Ambulan			
Kondisi Pasien				
Sebelum Transfer				
TD	Nadi	RR	Tax	Saturasi GCS
142/96 mmHg	73 x/mnt	32 x/mnt	C	100 % 323
Catatan: Tanggal transfer 11/06/2026 pukul 15 WIB Petugas penyerah pasien,				
Setelah Transfer				
TD	Nadi	RR	Tax	Saturasi GCS
109/70 mmHg	70 x/mnt	36 x/mnt	MIST C	97% 323
Catatan: Tanggal tiba 11/6/2026 pukul 15:15 WIB Petugas penerima pasien				



Dokumentasi





